



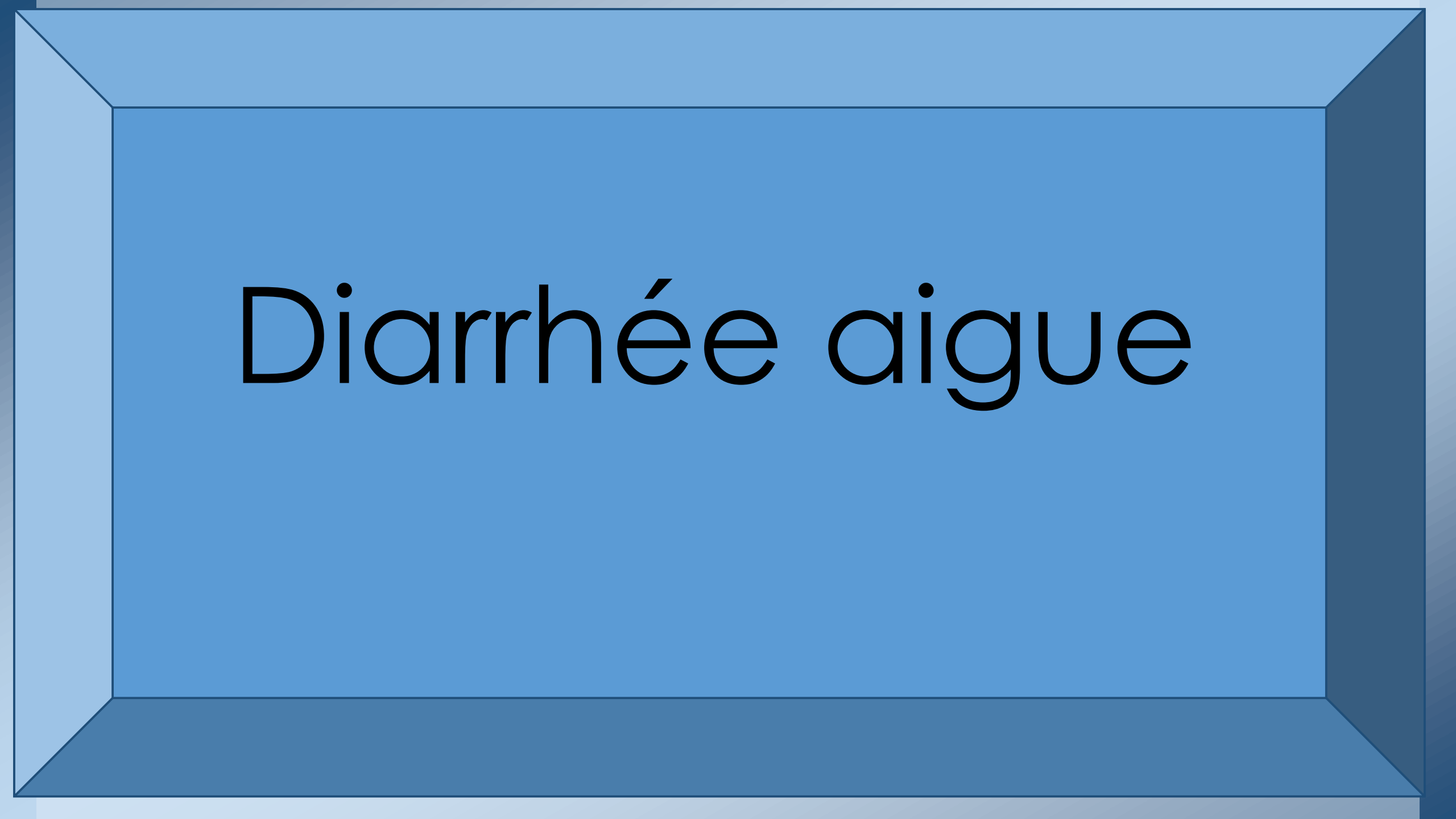
Sémiologie Digestive
Service Médecine Interne CHU Benbadis
Constantine Université Constantine 3

Diarrhée aiguë et chronique

Dr Merzougui A.I

définitions:

- Diarrhée (OMS): émission d'au moins 3 selles molles ou liquides/ j, ou à une fréquence anormale pour l'individu (≠ selles fréquentes prandiale du nourrisson au sein)
- définie par l'existence de selles trop abondantes (supérieures à 300 g par 24 h) et/ou trop fréquentes (supérieures à 3 par jour) et/ou trop liquides (poids sec inférieur à 25 %)
- -Diarrhée aiguë: durée < 14 jours
- -Diarrhée persistante: 14 jours ou plus
- - Diarrhée chronique: durée d'au moins 3 semaines
- - Dysenterie: présence de sang dans les selles (quelque soit la fréquence des selles)



Diarrhée aiguë

introduction

- est l'émission de selles trop abondantes et/ou trop fréquentes et/ou trop liquides, évoluant depuis **plusieurs jours**, de survenue **brutale**, mais qui ne dure habituellement que quelques jours et rarement plus de 10 jours
- Motif fréquent aux urgences
- Généralement bénin mais peut se compliquer
- Etiologie plus fréquente est l'infection (virale++)

physiopathologie

A/Diminution de l'absorption :

1/Destruction de l'épithélium: exemple : Le ROTAVIRUS+++ .

2/Production des cytokines : exemple : SHIGELLA+++

3/Invasion épithéliale: lors du syndrome dysentérique (glaise et sang) :
exemple : SALMONELLES, SHIGELLES

4/Troubles de la motricité digestive: soit par accélération du transit, ou
motricité inverse (accompagnée par des vomissements).

B/Augmentation de la sécrétion intestinale :

(élaboration des toxines) : exemple : CHOLERA+++

classification

les diarrhées sécrétoires:

- non invasives, non inflammatoires, sans fièvre, généralement aqueuses et volumineuses

les diarrhées inflammatoires:

caractérisées par la présence de fièvre, de douleurs abdominales, de ténesmes, de mucus et/ou de sang dans les selles.

étiologies

La diarrhée aiguë médicamenteuse

- prise d'antibiotiques +++
- une modification du transit intestinal dans 10%
- pendant le traitement et jusqu'à deux mois après son arrêt due à :
 - La capacité de fermentation du microbiote colique partiellement décimé
 - Parfois celle-ci est provoquée par la prolifération opportuniste de germes pathogènes

Autres médicaments: □ d'anti-inflammatoires non stéroïdiens □ la colchicine □ certaines chimiothérapies anticancéreuses

étiologies

La diarrhée aiguë « ischémique » :

- les patients à risque vasculaire sont plus susceptibles de souffrir par défaut d'oxygénation de la muqueuse intestinale

Une entéropathie chronique

(maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique) peut se révéler par une diarrhée aiguë, alors d'origine inflammatoire

Rareté : Invagination intestinale aiguë, Insuffisance Surrénale Aigue (hypo natrémie, hyperkaliémie, hypernatriurie), hyperthyroïdie

Causes infectieuses

bacterie	virus	parasite
Escherichia coli diarrhéogène Campylobacter jejuni Vibrio cholerae O1 V. cholerae O139* Shigella species Bacteroides fragilis C. coli C. upsaliensis Salmonellae nontyphoïde Clostridium difficile Yersinia enterocolitica Y. pseudotuberculosis	Rotavirus Norovirus (calicivirus) Adenovirus (sérotipe 40/41) Astrovirus Cytomegalovirus*	Protozoaire : Cryptosporidium parvum Giardia intestinalis Entamoeba histolytica Cyclospora cayetanensis Dientamoeba fragilis Blastocystis hominis Helminthes: Strongyloides stercoralis Angiostrongylus costaricensis Schistosoma mansoni, S. japonicum

L'interrogatoire

recherche:

- d'une origine infectieuse de la diarrhée aiguë (contexte épidémique et/ou vie en collectivité)
- prise récente de médicaments ou d'antibiotiques
- voyage récent (moins de 8 jours) en zone tropicale ou dans le bassin méditerranéen,
- immuno-dépression spontanée ou induite
- la prise d'aliments vecteurs d'agents infectieux (œuf cru, produits laitiers non pasteurisés, viande de bœuf insuffisamment cuite)

L'interrogatoire

- des caractéristiques pouvant évoquer une origine particulière : -la survenue d'une diarrhée au cours d'un repas ou immédiatement après celui-ci, évoquant une diarrhée allergique (urticaire associé, œdème de la face)
- ingestion de pâtisserie, de glace avec des vomissements associés évoluant en moins de 24 h avec une incubation courte de 1 à 6 h évoquant une intoxication par staphylococcus aureus...

L'examen général

recherchera des signes systémiques en particulier

- de déshydratation (soif, sécheresse muqueuse, hypotension, tachycardie, oligurie),
- une fièvre ou frissons

des signes extra-digestifs : l'existence d'un érythème noueux, d'une arthrite réactionnelle (infection par *Campylobacter* ou *Yersinia*)

Aspect des selles: aqueux (sécretoire) glaireux ou glairo-sanglant avec syndrome dysentérique (inflammatoire)

Douleur abdominale modérée (sécrétoire) ou violente (inflammatoire)

Examens paracliniques

- Bilan sanguin : Dans tous les cas : formule sanguine et CRP, ionogramme sanguin, créatininémie, protéines En cas de sepsis, $T > 38^{\circ}\text{C}$: hémocultures
- ☐ Recherche de leucocytes dans les selles en association avec une culture de selles en cas de doute par rapport à une éventuelle dysenterie.
- Examen bactériologique des selles
- Examen parasitologique des selles

Diagnostic différentiel

- **La diarrhée prandiale** du nourrisson au sein : c'est des selles semi liquides émissent lors ou après les tétés avec une bonne prise pondérale+++.
- Épisode de diarrhée aigüe sur un fond de diarrhée chronique.
- **Débâcle diarrhéique après constipation**
- Il ne faut considérer comme diarrhée: des selles fréquentes mais normales.

Evaluation clinique de la diarrhée

anamnèse	Examen clinique
Apparition, fréquence, type et volume des selles	Poids corporel
Présence de sang	Température
Vomissements	Fréquence cardiaque et respiratoire
Antécédents médicaux	Pression sanguine
Pathologies sous-jacentes	En pédiatrie: Présence de pathologies associées chez les enfants
Données épidémiologiques	

complications

- -DESYHDRATATION ISOTONIQUE • Perte équilibrée d'eau et de Na^+
- DESYHDRATATION HYPERTONIQUE • Perte d'eau >> perte de Na^+
- DESYHDRATATION HYPOTONIQUE • Perte d'eau << perte de Na^+
- ACIDOSE PAR DEFICIT BASIQUE
- □ HYPOKALIEMIE (importantes chez le NN et dangereuse chez le malnutri)
- Malnutrition, décès

« Drapeaux rouges : (péritonite, déshydratation, confusion rectorragie)

non

oui

hospitalisation

Situation à risque (âge extrême, co-morbidités importantes, immunosuppression, maladie inflammatoire chronique intestinale, utilisation récente d'atb)

non

oui

Dysenterie ? ($T^{\circ} > 38^{\circ}$, > 6 selles/24h, diarrhées muco-purulentes et/ou rectorragie)

non

oui

☐ Coproculture +/- autres prélèvements

☐ TTT symptomatique

☐ TTT symptomatique et ☐ Antibiothérapie empirique

Diarrhée chronique

definition

- -un poids des selles $> 300\text{g}/24\text{h}$ + une durée d'évolution supérieure à trois semaines.
- En pratique clinique, la diarrhée est généralement définie par des selles trop nombreuses ($\geq 3/24\text{h}$), trop abondantes et/ou liquides
- Le diagnostic positif d'une diarrhée chronique est clinique, il repose sur l'interrogatoire éventuellement associé à la pesée des selles

physiopathologie

- une sécrétion hydro-électrolytique dans l'intestin dépassant ses capacités d'absorption d'aval **diarrhée sécrétoire**
- un effet osmotique entraînant un afflux liquidien obligatoire du fait de la présence d'une substance osmotiquement active dans la lumière intestinale **diarrhée osmotique**
- une malabsorption excédant la capacité d'absorption et de fermentation de l'intestin d'aval **diarrhée de malabsorption**
- une accélération du transit telle que le temps nécessaire à l'absorption et à la fermentation n'est pas respecté **diarrhée motrice**

interrogatoire

- Antécédents personnels ou familiaux : cancer ou polypes recto coliques, maladie coéliquaue, maladie de crohn , néoplasie endocrinienne multiple
- Antécédents personnels : chirurgie digestive, radiothérapie abdominopelvienne, endocrinopathie (diabète, hyperthyroïdie)
- Habitudes : alimentaires, alcoolisme
- Les voyages faits avant le début de la diarrhée.
- des causes alimentaires (responsables d'un effet osmotique) : excès de lait, miel, fruits,sucreries.

Interrogatoire

- Tous les médicaments pris :

les AINS les antibiotiques les laxatifs le magnésium

- les médicaments susceptibles d'entraîner une diarrhée par action pharmacologique

- **inhibitrice de la digestion glucidique** (acarbose)
- par **toxicité entérocytaire** (colchicine, biguanides) ou en donnant naissance, souvent de façon soudaine et retardée
- à une **colite microscopique** (veinotoniques, lansoprazole,)

interrogatoire

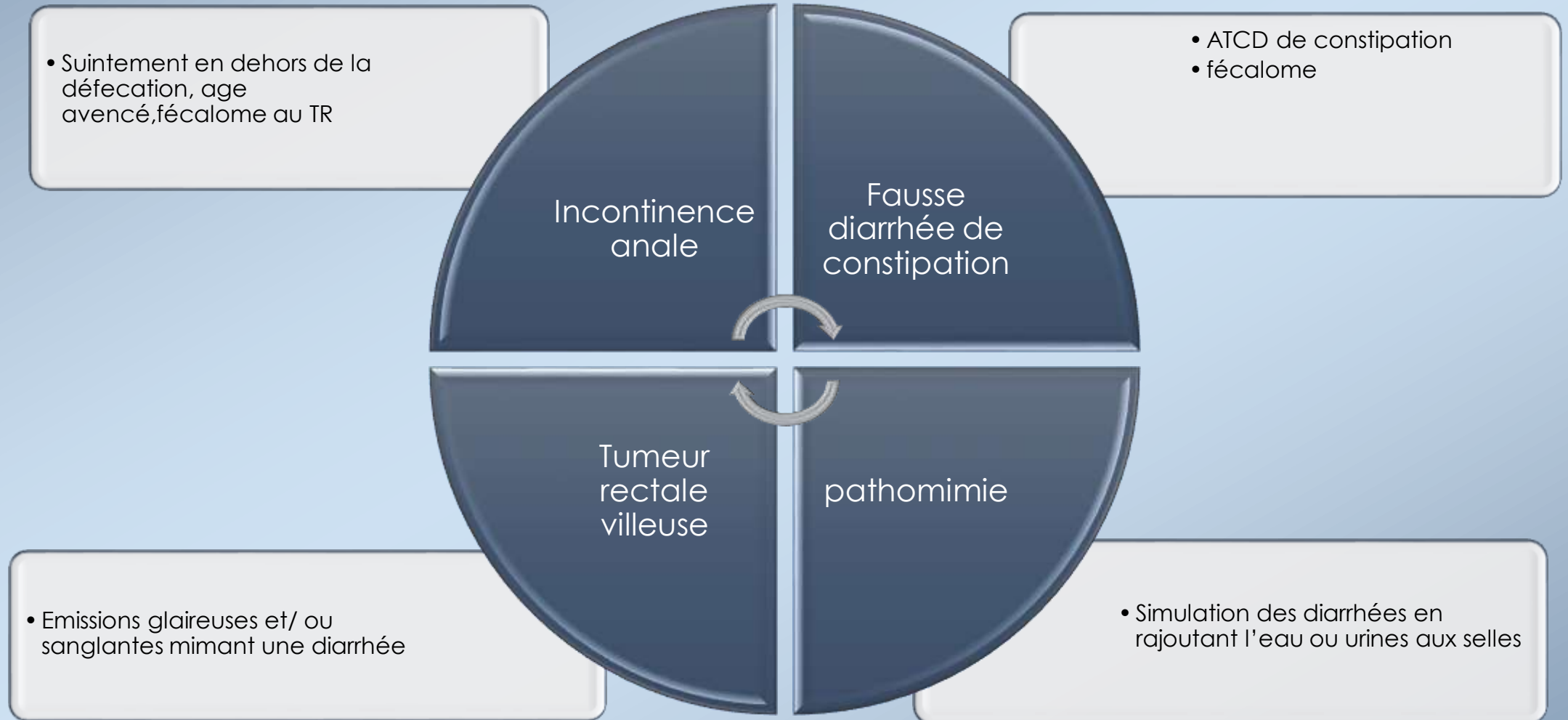
- Signes fonctionnels :
 - Mode d'installation: soudain, ou plus progressif, caractère continu ou intermittent,
 - L'aspect des selles : • volumineuses, • bouseuses • visiblement graisseuses (maldigestion), • aqueuse (diarrhée osmotique et/ou sécrétoire), • diarrhée hémorragique ou dysentérique (colite), présence dans les selles d'aliments non digérés ? (diarrhée motrice),
 - L'horaire des selles dans la journée et le rôle de l'alimentation
 - Signes digestifs: nausées ,vomissements,,
 - Signes extra digestifs

Examen clinique

- l'état nutritionnel et l'hydratation
- Recherche les signes de carence(fer, vitamine K,albumine,,)
- Des signes ou lésions cutanées muqueuses ou articulaires,
 - - Un goitre ; nodule ou souffle thyroïdien,
 - - Signes d'insuffisance cardiaque droit
 - – les vaisseaux périphériques et abdominaux (auscultation)
 - – les ganglions périphériques

- météorisme et flatulence, douleurs abdominale
- Palpation abdominale
- l'existence de flushs (brusque hyperthermie et rougeur du thorax ou du visage après les repas ou la palpation hépatique) évoquant un syndrome carcinoïdien (serotonine)
- - Examen proctologique (fissure, hémorroïdes..)

Diagnostic différentiel



Examens paracliniques

- à la recherche d'un syndrome carentiel biologique :
- NFS, ferritinémie, ionogramme sanguin, albuminémie, cholestérolémie, calcémie, prothrombinémie, +/- folates et vitamine B12, EPP.
- évaluer le retentissement hydro électrolytique et acido basique urémie, créatininémie ionogramme sanguin, réserve alcaline, ionogramme urinaire – urée -creat)
- Bilan thyroïdien
- Serologie virale et EPP

Examen morphologiques

- ASP et radio thorax
- Echographie abdomino-pelvienne
- Scanner abdomino pelvien,entero scanner,entero IRM
- Endoscopie:colonoscopie et fibroscopie avec biopsies

Les étiologies

Diarrhées avec malabsorption

- **Malabsorption pré-entérocytaire** : Pancréatite chronique, cancer du pancréas...
- **Malabsorption entérocytaire** : Maladie coéliquaue, Maladie de Whipple, Parasitose...
- **Malabsorption post-entérocytaire** : Lymphangiectasies intestinales primitive (Waldmann) ou secondaire. La lymphe ne pourra plus être drainée et cela sera renfloué dans la lumière intestinale

Les étiologies

diarrhée motrice

- **Endocriniennes** : Cancer médullaire de la thyroïde – Hyperthyroïdie – Syndrome carcinoïde
- **Neurologiques** : Vagotomie, sympathectomie – Neuropathies viscérales (diabète, amylose) par dysautonomie
- **Anatomiques** : Grêle court – fistule gastro-colique
- **Diarrhée motrice idiopathique** ($\approx$ la diarrhée émotionnelle) – (> 80% des cas)

Les etiologies

Diarrhées osmotiques :

On ingère volontairement ou involontairement des solutés peu ou pas absorbables osmotiquement actifs.

- Malabsorption **physiologique** de substances osmotiques : lactulose ou lactitol, mannitol, sorbitol, ions sulfate, phosphate et magnésium
- Malabsorption **pathologique** des sucres : déficit en lactase et en saccharase-isomaltase

Les étiologies

Diarrhées sécrétoires

Diarrhées sécrétoires lésionnelles:

les Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) : Colite ischémique, entérocolite radique, colite infectieuse (immunodéprimés++), cancer rectocolique et tumeur villeuse

Diarrhées sécrétoires hydriques (non lésionnelles) :

Colites microscopiques :

souvent oubliées, le diagnostic passe par la biopsie, donc si on fait une entéroscopie, on pratique de manière systématique une biopsie. -
Médicaments (biguanides, colchicine...)

Points forts à retenir :

- Si les causes de diarrhées chroniques sont nombreuses, l'examen clinique méticuleux permet souvent de suspecter le diagnostic.
- Lorsque ce n'est pas le cas, une enquête méthodique doit être mise en œuvre, qui débute par des explorations morphologiques de l'intestin ou de la sphère biliopancréatique.

bibliographie

- Diarrhée de l'enfant: Dr SEUNGUE Judith Pédiatre CME/FCB, centre pasteur du cameroun
- World Gastroenterology Organisation Global Guidelines La diarrhée aiguë chez les adultes et les enfants: une approche globale Février 2012
- FMC 2011: diarrhée chronique; P. Marteau, B. Coffin